

手術時の輸液準備

全身麻酔、腰椎麻酔の術前輸液は
輸液ポンプで管理する。

- プラネクタ20滴輸液セット3連を使用する
- 留置針と輸液セットの接続はロックしない

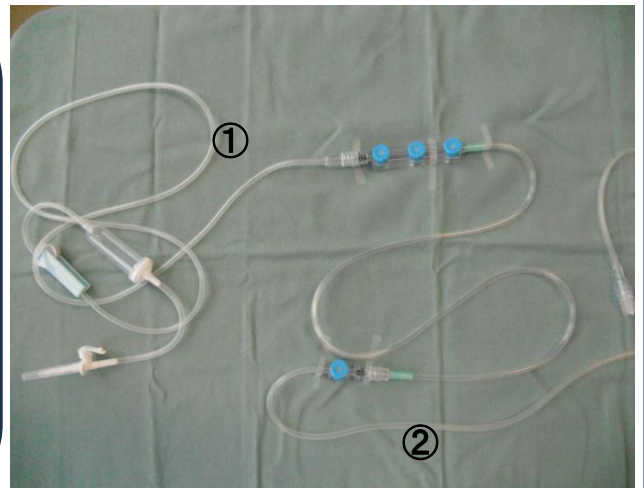


● 長いラインが必要な手術

頸椎手術、下肢にラインをとる場合
腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術
直腸がん手術
腹腔鏡下虫垂切除術で左上肢にルートをとる場合
尿管管切除術で右上肢にルートをとる場合

★長いラインの作り方★

プラネクタ20滴輸液セット3連(輸液側①)に、
プラネクタ20滴輸液セット1連(患者側②)を
プラネクタ部分から外して接続する。



● 留置針は20Gが第一選択。

20Gでルートが取れない場合は、22Gを使用する。

● 点滴ルートをとる部位

・点滴ルートは、患側と反対側にとる。患部に左右が無い場合は、左手にルートをとる。両上肢骨折時には手術する方と反対側の下肢にルートをとる。(下肢のルートの取り方は上記) 迷った時は手術室に連絡し、相談する。

・特例 頸椎手術の場合 ①前方固定術の場合 左手 ②後方固定術の場合 右手

＊いずれも、決められた部位にルートが取れなかった場合は、患者が手術室に入る前に手術室に連絡する。

● 点滴ルートの固定時のポイント

固定には、テガダームとメディカルバンを用いて行う。点滴ルートの長さを、できるだけ長い状態で使えるように固定するため、穿刺場所の第一選択は手背とする。手背に取れない場合は、できるだけ末梢側を選択する。



● 小児の輸液管理

- ・輸液ポンプを使用して、速度管理を行う。
- ・9歳以下は60滴輸液セット、10歳以上は20滴輸液セットを使用する。
- ・幼児の場合は、訴えが明確でないため、点滴漏れをした場合、発見が遅れる場合もある。刺入部の観察を頻回に行うとともに、付き添っている家族にも協力を依頼する。



